

Hépatites virales:

Hépatite A:

- Picornaviridae
- Génome RNA sb
- Non-enveloppé, capside hautement résistante
- Transmission féco-orale (parentérale très rare). aliments/eau contaminés, contact personnel rapproché
- Manifestat° cliniques: incubat° 2 sem - 2 mois, symptômes p°lt 2-12 sem. Bon pronostic, pas de chronicité, rare évolut° fulminante, cholestatique ou récidivante.
- Prévent°: immunisat° active (vaccin inactivé), immunisat° passive (Ig), hygiène.

Hépatite B:

- Hepadnaviridae
- Génome à DNA double brin partiel.
- Enveloppé (HBsAg), capside
- Cycle vie: virus affecte foie et dépose du cc DNA dans génome hépatocyte (pas intégré au génome). Reste tte la vie, se réplique en m tps que la δ $\rightarrow$ peut réact. hépatite 30 après si immunosuppr.
- Transmission parentérale, mère-enfant/périnatale (verticale), petite enfance, transm. sexuelle.
- Diagnostic: - tests sérologiques: HBsAg (infect° aiguë/chronique), anti-HBs (infect° résolue/vaccinat°), anti-HBe (actuelle/passée), HBeAg (réplicat° active), anti-HBe (inactive ou mutante)
- tests nr: HBV DNA, HBV génotypes, tests de résistance.
- Evolut°: Hépatite aiguë $\xrightarrow[\text{>95\% à 1-12}]{\text{<5\%}}$ Hép. chron. $\xrightarrow[\text{0,2\%/an}]{\text{20-30\%}}$ cirrhose $\xrightarrow[\text{1-6\%/an}]{\text{1-6\%/an}}$ CHC. On peut passer de l'hép. chron. au CHC sans passer par cirrhose. Seule hépatopathie d'sa cas
- Prévent°: dépistage, dépistage p°lt grossesse, immunisat° active (vaccin), immunisat° passive (Ig). Vaccin: HBsAg

$\rightarrow$ Ig anti-HBs

		HBsAg	HBeAg	HBV DNA	ALAT
• Classificat°:	- Hép. B. chron. HBsAg $\oplus$	+	+	$10^5 - 10^8$ +++	$\uparrow$
• Considérer Htt	- " " " " $\ominus$	+	-	$10^3 - 10^4$ ++	$\uparrow$
• Suivi (ALAT $\pm$ AFP/US)	- Porteur inactif HBsAg	+	-	$< 2 \times 10^3$ +	=
	- Immunotolérant	+	+	$10^2 - 10^{10}$ +++	=
	- Hépatite B guérie	-	-	-	=

- Thérapie de l'hép. B chron.: - IFN- α pegylé (PEG-IFN- α): +: durée définie, rép. soutenue
-: effets 2nd, contre-indicat°
- Analogues nucléos(t)idiques: +: tolérance, utilisat° facile
-: durée indéfinie, résist.

Hépatite C:

- Flaviviridae
- Génome RNA sb, variabilité génétique.
- Enveloppé, capside

- Transfusions sang + prod. sanguins avant 1990, drogues i.v., transmission sexuelle et mère-enfant rare.
- Diagn. hép. C chron.: anti-HCV (+), ALAT perturbée, PCR: HCV RNA
- Evolut°: Hépatite aiguë 50-80% → Hép. chron. 2-3% en 20ans → cirrhose 1-6%/an → CHC. Une fois qu'on a dévelé cirrhose → risque CHC. Hép. C est la cause la + fréq. de cirrhose et CHC.
- HCV est un virus qu'on peut éliminer, obtenir rép. au ttt → élim virus. Pas de réactivat° (sauf si réinfect°) car pers de matrice qui reste ds foie.

Hépatite D: ^{L'IgG restants ne sont pas protecteurs, empêchent pas réinfect°.}

- HDV, agent sous-viral dépendant d'HBV.
- Génome à RNA sb circulaire
- Transmission parentérale bassin méditerranéen et pays est.
- Diagnostic: anti-HDV
- Evolut°: co-infect° vs. surinfect°. Evolut° fulminante ds 5% cas. chronicité dans 2% vs. 90%.
Forme d'hép. chron. la + virulente, évolut° fréq. et rapide → cirrhose, risque accru CHC.
- HBV DNA svt supprimé qd surinfect° par HDV → hép. D chron. Reste HDV RNA et HBsAg.

ttt: IFN- α pegylé ou Transplant. hépatique.

Hépatite E:

- HEV, Hepevirus
- Génome à RNA sb
- Transm. féco-orale
- Pays en voie dévelpmt, cas autochtones.
- Hépatite aiguë (chronique si post-transpl.).
- 20% mortalité post grossesse
- Diagnostic: HEV RNA, anti-HEV.